

סכמת טיפול בפצוע בודד

לא ראית = לא זיכית

בטחון המטפל והמטופל	S
התרשמות מזירת האירוע ומנגנון הפציעה:	
קבלת דיווח, בחינה ויזואלית, סיפור מקרה	
עצירת דימום משמעותי כולל אזור מעבר (בית שחי, מפשעה)	
דיווח ראשוני	

A V P U בדיקת הכרה	A
התרשמות מדרכי האוויר של הפצוע: התבוננות, קולו של הפצוע, פתיחת פה (בדיקת הפרשות / סימני כוויות או שאיפת עשן בלוע), בדיקת צווארו של הפצוע (סימני חבלה / המטומה מתפשטת)	
סילוק הפרשות במידת הצורך	
פתיחת נתיב אוויר: הטיית ראש לאחור / J.T בחשד לעמ"ש/צ	
החדרת מנתב אוויר	
קבלת החלטה בנוגע לנתיב אוויר דפניטיבי	
התרשמות מחבלה / דימום קרקפת, פנים, עורף, צוואר	

חשיפת בית חזה: התרשמות מחבלה / פציעה חודרת	B
בדיקת נשימה איכותית ועליית בית חזה דו"צ: 2 ידיים על בית החזה / האזנה	
בדיקת נשימה כמותית (30 שניות)	
N.A וקבלת החלטה בנוגע לנתיב אוויר דפניטיבי /או נקז חזה	
מתן חמצן וניטור סטורציה	

בדיקת דופק איכותי רדיאלי / פמורלי / קרוטידי (נמוש / לא, איטי / מהיר, חלש / חזק), כמותי (15 שניות)	C
התרשמות מסימני הלם נלווים: חיזור, הזעה, טמפי עור נמוכה, מילוי קפילרי איטי	
אופציה לפינוי מיד, השלמת סכמה במהלך הפינוי, דיווח!	
פתיחת וריד איכותי	
החלטה על טיפול תרופתי ובקרת נוזלים	
חיפוש אחר דימומים נוספים ועצירתם ע"י חבישה / פקינג	

30
שניות

A V P U בדיקת הכרה חוזרת: במידה ויש הדרדרות במצב ההכרה יש לחזור לשלב הA	D
בפצוע מחוסר הכרה בדיקת אישונים: סימטריה, גודל צר / מורחב ותגובה לאור	
בדיקת תנועת גפיים בהוראה לקול בפצוע בהכרה (ידיים ורגליים)	
התרשמות מחבלה / דימום באזור מעבר בית שחי / מפשעה, אגן, ידיים ורגליים	
הערך GCS	

השלמת הפשטה מלאה ועצירת דימום עם מציאתו	E
השלמת בדיקת גוף כללית	
ראש * צוואר * עורף * חזה * בטן * בית שחי * ידיים * אגן * מפשעה * רגליים * גב הפיכה 2 הצדדים	
השכבה על אלונקה: בידוד מהקרקע וכיסוי הפצוע, קיבוע לוח גב בעת הצורך	
הכנה לפינוי	
דיווח: דגש על דחיפות הפינוי והעברת דיווח בהקדם ליעד הפינוי	

המשך טיפול ע"פ הממצאים והאבחנה	סקר החייה
ניטור והערכה מחודשת של הפצוע	סקר שניוני
המשך ביצוע אנמנזה מקיפה יותר	
טיפול בכאב	
חבישות, קיבועים והמרות במידת הצורך	

הגדרת נפגע לא יציב

חסימה או איום על נתיב האוויר וכשלון הניסיונות למתן מענה
בעיה נשימתית (טכיפניאה <30 או ברדיפניאה >8 או סטורציה >90%) שלא נפתרה
חשד לדימום פנימי בלתי נשלט (צוואר, חזה, בטן, אגן) המלווה בסימני הלם
סבירות גבוהה להתדרדרות משמעותית במצב הרפואי בטווח של דקות
צורך בהליך רפואי חיוני שכשל (אינטובציה, גישה ורידית, ניקוז חזה)

אין להתעכב בשטח למעט פעולות מצילות חיים. יש להיערך לפינוי מיידי

טיפול בנפגע לא יציב בזמן פינוי

ניטור מדדים חיוניים ומצב הכרה. מדד גלזגו
השגת גישה ורידית או IO
שקול מתן עירוי נוזלים או פלזמה
שקול מתן הקסקפרון
העבר דיווח מקדים לבית החולים
שקול טיפול בכאב
בצע הערכות מדדים חוזרות

טיפול בנפגע יציב בזמן פינוי

נטר מדדים חיוניים ומצב הכרה
שקול התקנת עירוי וביצוע פעולות משלימות
שקול צורך בדיווח מקדים לבית החולים
הערך את רמת כאב וטפל בהתאם
בצע הערכות מדדים חוזרות

יעדי פינוי

נפגע לא יציב - פנה לבית החולים הקרוב!
פגיעת ראש מבודדת + נפגע יציב - שקול פינוי למרכז נוירוכירורגי
זמן פינוי ממושך - שקול חבירה למסוק
זמני פינוי דומים - העדף פינוי למרכז-על

דיווח לבית חולים

מין, גיל
יציב/לא יציב/הכרה/מונשם
תאור האירוע, קינמטיקה, גובה, נשק
תאור הפגיעה העיקרית
זמן לבית חולים
מבקש חדר הלב

הגדרת חומרת פגיעה

פצוע קל – פצוע שאין לו סימנים לפגיעה במערכות חיוניות/מרכזיות כמו לב, ראש, חזה, בטן או שאין לו סימנים לסכנה לאיבר.

פצוע בינוני – פצוע עם סכנה לאיבר או פצוע עם פגיעה במערכת מרכזית אבל ללא סימנים וסימפטומים שמאששים את הפגיעה (לדוגמא – פצוע עם חבלת ראש קשה ללא שינויים במצב הכרה).

פצוע קשה – פגיעה במערכת מרכזית עם סימנים לכך – פצוע בטן שוקי, פצוע חזה, עם סימנים של מצוקה נשימתית.

אנוש – פצוע עם פגיעה במערכת מרכזית ושיש לו ירידה או אין לו אחד מסימני חיים (מוח או נשימה).

מדד גלזגאו

4	ספונטנית	פקיחת עיניים
3	להוראה	
2	לכאב	
1	אין	
5	מתמצא	דיבור
4	מבולבל – משפטים ללא הקשר נכון	
3	משמיע מילים – מילים בודדות	
2	משמיע קולות	
1	אין	
6	ממלא פקודות	תנועה
5	ממקם כאב (אפילו מנסה לסלק את מקורו)	
4	נסוג לכאב (מזיז רפלקסיבית את האיבר הכואב, בורח)	
3	מכופף לכאב (מתכווץ פנימה - דקורטיקציה)	
2	מיישר לכאב (נמתח החוצה - דצרברציה)	
1	אין	

התדרדרות מדד גלזגאו בשתי נקודות = פגיעת ראש קשה.